

PSICÓLOGO · PSICOTERAPEUTA TRANSPERSONAL

Preparación e *integración*

Un mapa de cuidado antes, durante y después de una experiencia en estados ampliados de conciencia.

Isaac Calderón Derat

Ciudad de México · isaaccalderon.me · psic@isaaccalderon.me

Cómo usar esta guía

Escribí esta guía para las personas que acompaño y para quienes están considerando una experiencia en estados ampliados de conciencia, ya la vivieron, o forman parte de la red de apoyo de alguien que la vivió.

No enseña a conseguir, dosificar ni administrar sustancias, y no sustituye una evaluación médica, psicológica o psiquiátrica. Es un mapa para hacer mejores preguntas, reconocer límites y traducir una experiencia intensa en cuidado cotidiano.

Puedes recorrerla de principio a fin o ir directo a la sección que corresponda a tu momento. Hay espacios para escribir: úsalos, o no. Este documento es tuyo.

Tres ideas para orientarte

1. **La sustancia no es la terapia.** Una experiencia puede abrir posibilidades, pero el cambio depende del contexto, las relaciones, el seguimiento y lo que se practica después.
2. **Difícil no significa dañino; pero tampoco todo sufrimiento es terapéutico.** La seguridad se evalúa por el funcionamiento, la capacidad de pedir ayuda y la presencia de riesgo real.
3. **Integrar no es encontrar una explicación definitiva.** Es relacionarte con lo vivido con curiosidad, cuerpo, tiempo, discernimiento y acciones sostenibles.

La preparación no busca controlar la experiencia. Busca crear condiciones para que lo que ocurra pueda ser sostenido, escuchado e integrado.

1 La pregunta central

Antes de pensar en sustancia, fecha o facilitador, la pregunta es otra:

¿Hay condiciones para que lo que se abra pueda ser sostenido?

La respuesta no depende sólo de cuánto desees la experiencia. Incluye tu estado físico y emocional, el entorno, la calidad del acompañamiento, los límites, el consentimiento y la red disponible después.

Inventario breve

- ¿Tengo estabilidad básica en sueño, alimentación, vivienda y relaciones?
- ¿Estoy atravesando una crisis activa, un duelo reciente o una urgencia extrema?
- ¿Puedo decir «no», pedir una pausa y cambiar de opinión?
- ¿Conozco los límites y la formación de quien acompaña?
- ¿Existe un plan si me desregulo o necesito atención médica?
- ¿Tengo apoyo disponible en los días posteriores?
- ¿Estoy dispuesta o dispuesto a integrar, aunque la experiencia no sea la que espero?

Pausar no es fracasar. Pausar también puede ser una forma profunda de cuidado. En mi práctica, más de una vez la decisión más terapéutica ha sido esperar.

2 Preparación: cuatro capas

Conviene mirar la preparación en cuatro capas interdependientes. Ninguna garantiza una experiencia «buena»; juntas permiten valorar si existe un contenedor suficiente.

Capa corporal

El cuerpo no es el vehículo que te lleva a la experiencia: forma parte de ella. Observa sueño, descanso, alimentación, enfermedad reciente, dolor, agotamiento y uso de medicamentos.

- No suspendas medicamentos ni cambies dosis sin acompañamiento médico.
- Consulta posibles interacciones con un profesional que conozca tu historia clínica.
- Evita llegar exhausto, deshidratado o en crisis.
- Practica formas sencillas de regulación que ya conozcas: caminar, respirar sin forzar, sentir los pies, descansar.

Capa emocional

No todo miedo significa «no»; tampoco todo deseo significa «sí». Un miedo que permite pensar y pedir apoyo puede expresar respeto por el proceso. Terror, presión, desesperación o la sensación de no tener opción piden pausa y evaluación.

- ¿Mi intención nace de curiosidad y cuidado, o de urgencia y escape?
- ¿Qué espero que la experiencia resuelva por mí?
- ¿Qué parte de mí quiere avanzar y qué parte necesita protección?
- ¿Podría aceptar que la experiencia no cumpla mis expectativas?

Capa relacional

Las personas no se regulan en aislamiento. Una apertura profunda necesita red, no sólo intensidad.

- ¿Quién estará presente y cuál es su función?
- ¿Cómo se acuerdan el contacto físico y los límites?
- ¿Qué ocurre si retiro mi consentimiento?
- ¿Quién sabe dónde estoy?
- ¿Quién puede acompañarme después sin imponer una interpretación?
- ¿Hay seguimiento o sólo una experiencia aislada?

Capa contextual

No existe un contexto automáticamente seguro por llamarse clínico, ceremonial, médico o espiritual. Cada uno tiene potencia y riesgos. Evalúa formación, selección de participantes, plan de emergencia, límites, número de

personas, privacidad, seguimiento y transparencia económica.

No es sólo qué sustancia. Es qué persona, en qué momento, en qué contexto, con qué sostén y para qué.

3 Intención encarnada

Una intención madura orienta; no controla. En lugar de buscar una frase perfecta, escucha cómo responde tu cuerpo.

Práctica de cinco minutos

1. Siente el peso de los pies y haz tres respiraciones cómodas.
2. Pregunta: «¿Qué necesito en este momento de mi vida?».
3. Deja que aparezca una palabra, una imagen o una sensación.
4. Nota dónde se siente: apertura, contracción, calma, urgencia o ambivalencia.
5. Pregunta: «¿De dónde viene esto: amor, curiosidad, cansancio, miedo o escape?».
6. Escribe una frase sin convertirla en mandato.

Mi intención provisional

Lo que necesitaría para sentirme sostenida o sostenido

4 Durante: orientación sin prescripción

Las experiencias pueden incluir cambios intensos en emociones, percepción, memoria, sentido de identidad y sensaciones corporales. Un *insight* puede sentirse absolutamente verdadero sin ser necesariamente un hecho verificable.

Tres anclas sencillas

1. **Orientación.** Nombra dónde estás, quién te acompaña y que el estado es temporal.
2. **Cuerpo.** Siente superficies estables, temperatura, postura y respiración sin forzar.
3. **Comunicación.** Expresa con claridad si necesitas menos estímulo, distancia, apoyo o atención médica.

El consentimiento es continuo. Haber aceptado participar no significa aceptar cualquier intervención. El contacto físico, los cambios de espacio y las decisiones clínicas requieren acuerdos claros y respetan un «no» en cualquier momento.

5 Las primeras 24 a 48 horas

Después de una experiencia intensa, prioriza aterrizaje y funcionamiento antes que interpretación.

Puede ayudar

- Dormir y recuperar rutinas básicas de alimentación e hidratación.
- Reducir compromisos y estímulos innecesarios.
- Registrar recuerdos sin exigir coherencia.
- Hablar con alguien capaz de escuchar sin dramatizar ni idealizar.
- Posponer decisiones irreversibles hasta recuperar estabilidad y perspectiva.

Conviene evitar

- Convertir de inmediato cada imagen en una certeza literal.
- Publicar detalles íntimos por impulso.
- Tomar nuevas sustancias para «completar» o corregir lo vivido.
- Aislarte si notas confusión, miedo o deterioro de tu funcionamiento.
- Permitir que otra persona defina por ti el significado de la experiencia.

6 Qué significa integrar

Bathje, Majeski y Kudowor describen la integración como un proceso activo de revisar, trabajar, traducir y procesar una experiencia para incorporar gradualmente aprendizajes a la vida. No existe una única técnica ni un plazo universal.

Integrar es pasar del insight al hábito, del símbolo a la relación, y de la experiencia extraordinaria a una vida cotidiana más habitable.

Integración sí es

- Dar tiempo a que el significado cambie.
- Contrastar *insights* con la realidad y con personas confiables.
- Cuidar cuerpo, relaciones, descanso y límites.
- Traducir una comprensión en una acción pequeña y repetible.
- Buscar apoyo cuando el material excede tus recursos actuales.

Integración no es

- Obedecer toda revelación como mandato.
- Demostrar que la experiencia fue profunda.
- Repetir experiencias para evitar el trabajo cotidiano.
- Adoptar la cosmovisión de quien facilita.
- Llamar «sanación» a un deterioro persistente del funcionamiento.

7 Seis territorios para revisar

El Modelo Sintetizado de Integración organiza el proceso en seis dominios. Úsalos como preguntas, no como una lista que debas completar.

Mente

¿Qué creencias se flexibilizaron? ¿Qué interpretación necesita permanecer provisional? ¿Qué hechos puedo verificar?

Cuerpo

¿Cómo están mi sueño, apetito, energía, tensión y sensación de seguridad? ¿Qué práctica corporal me ayuda a volver al presente?

Espíritu y sentido

¿Cambié mi relación con el propósito, la muerte, lo sagrado o la pertenencia? ¿Puedo honrarlo sin usarlo para evitar dolor psicológico o responsabilidades concretas?

Relaciones

¿Qué conversaciones, reparaciones o límites aparecen? Poner un límite también puede ser integración.

Vida cotidiana

¿Qué cambio pequeño sería observable y sostenible durante las próximas dos semanas? Evita planes grandiosos; elige una práctica que pueda repetirse.

Naturaleza y contexto

¿Cambié mi relación con el mundo natural, mi comunidad o las culturas de las que provienen ciertas prácticas? ¿Cómo puedo responder con reciprocidad y cuidado?

8 Tu mapa de integración

Completa este mapa varias veces: al día siguiente, una semana después, y cuando cambie tu comprensión. Que las respuestas cambien es señal de que el proceso está vivo.

Lo que viví

Lo que siento en el cuerpo al recordarlo

El significado provisional que le doy hoy

Lo que todavía no sé

Una acción pequeña y verificable

La persona o el recurso que puede sostenerme

9 Prácticas de integración

Elige pocas prácticas y observa su efecto. Más actividad no equivale a más integración.

Escritura

Registra escenas, emociones, sensaciones y preguntas. Distingue entre «lo que ocurrió», «lo que interpreté» y «lo que quiero explorar».

Focusing o escucha corporal

Nota una sensación concreta antes de explicarla. Dale una palabra o imagen provisional y pregunta qué necesita. Si esto aumenta mucho la activación, detente y busca acompañamiento.

Arte y simbolización

Dibujo, música, movimiento o collage pueden dar forma a contenido que todavía no cabe en palabras. La obra no necesita ser bonita ni interpretada.

Conversación y comunidad

Comparte con alguien que escuche sin convertir tu experiencia en diagnóstico, profecía o doctrina. Pregunta antes si la otra persona tiene capacidad para recibir el relato.

Acción cotidiana

Convierte un *insight* en una conducta delimitada: una conversación preparada, una hora de sueño protegida, una cita profesional, un límite, o diez minutos de práctica diaria.

10 Discernimiento y ética

Marc Aixalà propone una postura de no directividad, colaboración, curiosidad, compasión, límites y humildad. Sirve también para evaluar a quien te acompaña — incluido yo.

Una persona acompañante responsable

- No impone significados ni afirma conocer tu «verdad profunda».
- Distingue apoyo de psicoterapia y reconoce sus competencias.
- Mantiene límites claros, especialmente en estados de vulnerabilidad.
- No sexualiza la relación ni usa el contacto físico de forma ambigua.
- Acepta supervisión, deriva cuando corresponde y documenta acuerdos.
- No promete curación ni atribuye todo malestar a un «proceso espiritual».

Las experiencias místicas, energéticas o de unidad pueden ser significativas. También pueden coexistir con insomnio, manía, psicosis, disociación u otras condiciones que requieren evaluación. **Ninguna interpretación espiritual debe retrasar ayuda clínica cuando existe riesgo o pérdida de funcionamiento.**

11 Señales de cuidado y señales de alerta

Indicadores de integración saludable

- Recuperas o mejoras gradualmente el sueño y las rutinas.
- Puedes sostener ambigüedad sin actuar impulsivamente.
- Aumenta tu conexión con el cuerpo y con personas confiables.
- Los cambios son pequeños, observables y compatibles con tus responsabilidades.
- Puedes pedir ayuda y aceptar retroalimentación.

Busca apoyo profesional pronto si

- El miedo, la confusión, la despersonalización o el insomnio persisten o aumentan.
- Hay deterioro en trabajo, estudio, autocuidado o relaciones.
- Aparecen pensamientos suicidas, conducta peligrosa, agitación extrema, paranoia o pérdida de contacto con la realidad.

- No puedes alimentarte, dormir o mantenerte en seguridad.
- La experiencia activó un trauma que te desborda.

EMERGENCIA

Si existe peligro inmediato, riesgo suicida o una emergencia médica o de salud mental, contacta los servicios locales de emergencia. En México, la Línea de la Vida atiende las 24 horas en el **800 911 2000**. Los servicios de integración y las líneas de apoyo no sustituyen atención de urgencia.

12 Plan personal de continuidad

En las próximas 48 horas

Mi prioridad corporal es

La persona a quien contactaré es

La decisión que voy a posponer es

Durante las próximas dos semanas

La práctica pequeña que probaré es

La señal que me indicará que me ayuda es

La señal que me indicará que necesito otro apoyo es

Mi red

Apoyo personal

Profesional de salud

Servicio de emergencia local

Si algo de lo que aparece en estas páginas necesita ser conversado, escríbeme. Acompaño procesos de preparación e integración en Ciudad de México y en línea.

Isaac Calderón Derat

Psicólogo · Psicoterapeuta Transpersonal

psic@isaaccalderon.me · isaaccalderon.me

Recursos

- **Línea de la Vida (México):** apoyo en crisis, 24 horas. 800 911 2000
- **ICEERS Support Center:** apoyo e integración de experiencias difíciles; no sustituye diagnóstico ni tratamiento. iceers.org/en/support-and-integration/
- **Fireside Project:** apoyo emocional entre pares; no es un servicio de emergencias. firesideproject.org
- **NCCIH:** información pública de seguridad sobre psilocibina. nccih.nih.gov

Referencias esenciales

- Aixalà, M. (2022). *Psychedelic Integration: Psychotherapy for Non-Ordinary States of Consciousness*. Synergetic Press.
- Bathje, G. J., Majeski, E. y Kudowor, M. (2022). «Psychedelic integration: An analysis of the concept and its practice». *Frontiers in Psychology*, 13, 824077.
- Gendlin, E. T. (1978). *Focusing*. Everest House.
- Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. (2025). *The MAPS Psychedelic Integration Workbook*.
- Richards, W. A. (2015). *Sacred Knowledge*. Columbia University Press.
- Schwartz, R. C. (2021). *No Bad Parts*. Sounds True.

Nota editorial y de seguridad

Esta guía es material educativo y de reducción de riesgos. **No constituye una recomendación para consumir sustancias, no contiene instrucciones de administración ni de dosificación, y no sustituye atención médica, psicológica o psiquiátrica.** Leerla no establece una relación terapéutica.

Adapta para mi práctica clínica el manual de preparación e integración de *Psicodélicos sin mitos* (Ciencia Psicodélica), y dialoga con el trabajo de integración de Marc Aixalà, *The MAPS Psychedelic Integration Workbook* y el Modelo Sintetizado de Integración de Bathje, Majeski y Kudowor.

© Isaac Calderón Derat. Puedes compartir este documento íntegro y sin modificaciones.